

KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

RESPONSABILE TELEMEDICINA

Telemedicina in area montana

Il kit del responsabile telemedicina

Materiale didattico — Workshop KIREO

Apri un'enoteca a Centocelle, Roma

Cosa devi produrre

La telemedicina in montagna ha due nemici: la connettività e l'età dei pazienti. Il tuo lavoro è progettare qualcosa che funzioni davvero con persone di 78 anni e con il segnale che va e viene.

La consegna richiesta

- Quali prestazioni di telemedicina attivare e con che priorità
- Requisiti tecnici minimi: connettività, dispositivi, postazione
- Come si gestiscono installazione, formazione e assistenza per gli anziani
- Piano B quando la connessione non c'è

Le tre telemedicines (non sono la stessa cosa)

Prestazione	Chi partecipa	A cosa serve	Requisiti
Televisita	Medico e paziente in collegamento	Visita a distanza, sostituisce quella in presenza in casi definiti	Video stabile, identificazione certa, referto firmato
Teleconsulto	Due professionisti sanitari	Il medico di base chiede un parere allo specialista sul caso	Anche asincrono. Requisiti tecnici più leggeri
Telemonitoraggio	Paziente a casa, dati al sanitario	Rilevazione continua di parametri: pressione, glicemia, saturazione, peso	Dispositivi, trasmissione dati, protocollo di allerta

*Per una popolazione anziana con cronicità, il **telemonitoraggio** è quello con l'impatto più alto: intercetta il peggioramento prima che diventi ricovero. La televisita è utile ma richiede più collaborazione dal paziente.*

Il quadro nazionale

Esiste una Piattaforma Nazionale di Telemedicina, disciplinata anche sul trattamento dei dati personali (DM 19 novembre 2025). I finanziamenti PNRR per la telemedicina sono stati ripartiti alle Regioni con decreti del 2023 e del 2025. Questo significa che non stai inventando: stai inserendoti in un'infrastruttura che esiste.

Il problema vero: la connettività

In Appennino il segnale mobile è discontinuo e la fibra spesso non arriva. Progettare telemedicina senza affrontare questo punto significa progettare qualcosa che non funzionerà.

Situazione	Cosa funziona	Cosa non funziona
Fibra o FWA nel presidio	Tutto: televisita, teleconsulto, upload dati	—
Solo 4G nel presidio	Televisita con qualità ridotta, teleconsulto, dati	Video ad alta definizione, esami pesanti
4G intermittente a casa del paziente	Telemonitoraggio con invio differito	Televisita programmata
Nessun segnale a casa	Dispositivi con memoria locale, scarico al presidio	Qualsiasi cosa in tempo reale

*Soluzione progettuale: il **presidio come punto di connettività**. Il paziente che non ha rete a casa viene al presidio per la televisita, dove la connessione è garantita. I dispositivi di monitoraggio salvano in locale e sincronizzano quando trovano rete o quando il paziente passa in ambulatorio.*

Progettare per un paziente di 78 anni

- Nessuna app da installare: il dispositivo si accende e funziona
- Nessuna password: identificazione tramite il presidio o l'infermiere
- Un solo pulsante dove possibile: misura e invia, niente menù
- Feedback fisico: un suono o una luce che conferma che ha funzionato
- L'infermiere installa a domicilio e spiega di persona, non per telefono
- Numero di telefono unico per l'assistenza, che risponde una persona vera

*La dottoressa ti chiederà: **chi installa, chi insegna, chi ripara?** Se la risposta è "il fornitore da remoto", il progetto fallisce. Serve una figura locale, che nel modello del presidio è l'infermiere di comunità.*

Le domande che la dottoressa ti farà

- "Chi va a casa della signora Maria a installare l'aggeggio?"
- "E quando si rompe? Deve andare a Bologna a farlo riparare?"
- "Se il telemonitoraggio segnala un'anomalia alle 3 di notte, chi risponde?"
- "Quanto costa ogni dispositivo? E chi lo paga, il paziente?"
- "Nel 2027 quando il PNRR finisce, questi apparecchi restano o li ritirano?"

Prossimo passo — progetta l'infrastruttura, poi vai nella chat preparato sulle domande pratiche di installazione e assistenza.